Curare non è solo guarire.

Dalle schede di Cicely Saunders alla preghiera per il malato

Materiale ad uso personale dello studente

Cicely Saunders ascolta le persone malate, registra le loro parole e raccoglie i dati su ciò che provano e sui trattamenti che ricevono. Lavora anche con schede perforate: sistemi di archiviazione usati prima dei computer che conosciamo. Arriva ad analizzare millecento casi. Il dato sorprendente è che si sta occupando di persone con un cancro in fase avanzata. Sta facendo ricerca proprio là dove qualcuno potrebbe pensare che non ci sia più nulla da scoprire, perché non si può più guarire. È lei stessa a raccontare questo lavoro in un articolo scritto molti anni dopo. [1]

Una cartella che resta aperta

Quelle schede pongono un problema concreto. Se possiamo registrare soltanto la scomparsa della malattia, molte rimarranno senza un risultato positivo. Se osserviamo anche il dolore, la possibilità di riposare, la paura, il rapporto con gli altri, scopriamo che esistono compiti precisi. Non cancellano la diagnosi, ma cambiano il modo in cui quella persona vive la malattia. Saunders unisce l'attenzione alle parole dei pazienti allo studio del sollievo dei sintomi. Ascoltare serve anche a capire che cosa sta accadendo; studiare serve a non affidarsi soltanto alle buone intenzioni. [1]

Nel 1967 apre a Londra il St Christopher's Hospice. Un hospice è un centro residenziale di cure palliative: accoglie persone che hanno bisogno di assistenza nella malattia grave, anche quando non è possibile guarirle. La novità del progetto di Saunders è unire la cura della persona alla ricerca e alla formazione di chi la assiste. Non è il primo luogo della storia in cui qualcuno si prende cura dei morenti. È un passaggio decisivo nella costruzione dell'hospice moderno, in cui l'attenzione al malato e il lavoro scientifico devono stare insieme.

Possiamo capire il problema senza conoscere una particolare malattia. Se una persona ha dolore, alleviarlo conserva uno scopo. Se teme di rimanere sola, qualcuno può esserle vicino. Se ha una domanda che nessuno ascolta, quella domanda non scompare perché i medici hanno già formulato la diagnosi. Sono bisogni diversi e chiedono risposte diverse. Non sarebbe serio promettere che tutto si risolverà; sarebbe altrettanto sbagliato cancellare tutti questi bisogni perché non possiamo ottenere il risultato che desideriamo di più. Quando la malattia non può essere eliminata, il lavoro della cura continua.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Una ricerca dentro la cura

Saunders, in «The evolution of palliative care» (Journal of the Royal Society of Medicine 94, 2001, pp. 430–432), ricorda il lavoro clinico e di ricerca al St Joseph's e l'analisi di 1.100 casi con schede perforate. Sono ricordi di Saunders, una fonte primaria retrospettiva: l'analisi non si può collocare dopo l'apertura del St Christopher's né considerare una sperimentazione clinica controllata. L'apertura del St Christopher's nel 1967 è attestata dai ricordi di Saunders. La continuità fra ascoltare, registrare e analizzare è esplicitata da Saunders stessa.

Di che cosa si occupa la cura

Per capire questo lavoro dobbiamo separare due parole che usiamo spesso come se fossero identiche: curare e guarire. Guarire è superare una malattia. Curare è occuparsi del bene della persona malata con interventi appropriati. La cura cerca la guarigione quando è possibile, ma comprende anche ciò che serve quando non arriva. In inglese si distingue fra to cure e to care: eliminare la malattia e prendersi cura. È un aiuto per ragionare, non una divisione fra medici che fanno scienza e altre persone che offrono umanità. Un medico può fare entrambe le cose; una visita affettuosa non sostituisce una competenza sanitaria.

Le cure palliative rendono concreta questa distinzione. Cercano di alleviare il dolore e gli altri sintomi, insieme alle difficoltà psicologiche, sociali e spirituali della persona. La parola palliativo viene talvolta usata per dire che un rimedio serve a poco. Qui, invece, indica un compito preciso: dare sollievo. Un trattamento può essere efficace rispetto a quel compito anche se non elimina la malattia. Perciò palliazione non significa assenza di terapia. Significa che dobbiamo domandarci quale bene quel trattamento può ottenere.

Saunders parla di dolore totale: la sofferenza non riguarda soltanto ciò che si può localizzare in una parte del corpo. Può comprendere paura, rapporti difficili, preoccupazioni per le persone care, domande sul significato di quello che si sta vivendo. Non sta dicendo che il dolore fisico sia immaginario. Sta chiedendo di non rendere invisibile tutto il resto. [1]

Facciamo un esempio inventato, non tratto dalle sue cartelle. Una persona riceve un trattamento che allevia il dolore, ma rimane preoccupata per il figlio che non vede e teme di essere diventata un peso. Il sollievo fisico è un bene reale. Non risponde, da solo, a ciò che la preoccupa. Per ascoltare quella paura occorre che qualcuno le lasci il tempo di parlare; per sostenere i rapporti familiari occorre capire la situazione concreta. La stessa persona ha bisogno di cure per il corpo, di ascolto e di relazioni. Non possiamo spezzarla in parti e dichiarare concluso il lavoro appena una sola è stata assistita.

Questo spiega anche che cosa significa accompagnare. Non obbligare il malato a essere ottimista, né riempire ogni silenzio. Essere presenti, ascoltare ciò che desidera dire, rispettare ciò che non vuole dire, collaborare con chi lo assiste. Si può stare accanto a qualcuno senza sapere come aggiustare tutto. Il limite delle nostre risposte non rende inutile la presenza; ci chiede di non usarla per imporre le nostre.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Una persona può avere ancora la stessa diagnosi e desiderare una conversazione, un incontro, un momento di quiete. Ascoltarla permette di capire che cosa le occorre oggi: anche questi desideri appartengono alla vita che sta vivendo e di cui ci prendiamo cura.

Quattro parole che si sovrappongono

Guarire indica il superamento di una malattia; curare indica le azioni appropriate rivolte al bene del malato, anche quando quell'esito non è ottenibile. La terapia è un trattamento e può avere finalità diverse: non è sinonimo esclusivo di guarigione. La palliazione mira ad alleviare sofferenza e sintomi; l'accompagnamento offre presenza e ascolto rispettando la persona. Le cure palliative integrano competenze mediche e infermieristiche con sostegno psicologico, sociale e spirituale. La distinzione inglese to cure/to care aiuta a non ridurre la cura all'eliminazione della malattia, ma non divide la realtà in due gruppi professionali contrapposti. Il medico si prende cura e un intervento palliativo può essere una terapia. Il «dolore totale» è il concetto con cui Saunders unisce sintomi fisici, sofferenza mentale e problemi sociali o spirituali. Non significa che il dolore fisico sia immaginario né che tutte le dimensioni siano sempre presenti con lo stesso peso. Il caso della persona che teme per il figlio è un esempio costruito per questa distinzione, non un caso clinico.

Una comunità presso il malato

Fra questi bisogni ci sono anche le domande spirituali. Che cosa significa ciò che mi accade? Posso ancora affidarmi a Dio? Che cosa resta dei rapporti e delle speranze della mia vita? Non tutti si pongono le medesime domande e non tutti hanno una fede religiosa. Saunders racconta che nel suo progetto c'era una cappella per il culto cristiano, ma nessuna pressione su pazienti o personale perché vi entrassero. Prestare attenzione alla vita spirituale di una persona non significa scegliere al suo posto che cosa deve credere. [1]

Per capire la risposta cristiana, cominciamo da un gesto accessibile anche a chi non sa curare una malattia: la visita. Nel Vangelo secondo Matteo, Gesù parla del giudizio finale e si identifica con chi ha ricevuto aiuto. Fra le azioni che ricorda c'è la visita al malato. La tradizione cristiana la riconosce come opera di misericordia: un modo concreto di soccorrere chi soffre. L'altro non è soltanto qualcuno di cui avere pietà; il rapporto con lui riguarda il rapporto con Cristo. [2]

La Chiesa non esprime questa vicinanza soltanto attraverso le visite. Nella lettera di Giacomo troviamo una scena precisa: un malato, la comunità chiamata a raggiungerlo, una preghiera e l'olio. Leggiamo:

> *«Chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati».*
>
> Bibbia CEI 2008, Gc 5,14–15 [3]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

La prima azione richiesta al malato è chiamare. I presbiteri sono i responsabili della comunità cristiana; sono loro a raggiungerlo, a pregare e a ungerlo nel nome del Signore. Il testo non lascia la persona sola a dimostrare quanta forza possiede. La malattia non cancella l'appartenenza alla comunità: è la comunità che si avvicina al malato. L'olio entra in una preghiera; non viene presentato come una sostanza capace, da sola, di procurare la salvezza.

La Chiesa cattolica riconosce in questo gesto uno dei suoi sacramenti, l'Unzione degli infermi. Infermi significa malati; unzione indica il gesto di ungere con olio. Un sacramento, per la fede cattolica, è un gesto attraverso cui Cristo comunica realmente il suo aiuto. Non è soltanto un modo visibile di esprimere l'affetto di chi è presente. La comunità crede che sia Cristo a raggiungere il malato e a sostenerlo attraverso quel gesto. [4]

Possiamo riconoscere il valore di un'assistenza offerta da chiunque e capire, nello stesso tempo, questa specificità. Chi riceve l'Unzione non chiede soltanto una visita ulteriore: chiede che la Chiesa preghi con lui e per lui, affidandolo al Signore. Per comprendere la richiesta non occorre essere credenti; occorre distinguere ciò che essa significa da una promessa medica o da un semplice incoraggiamento. [4]

La visita e la preghiera

Mt 25,31–46 è il quadro del giudizio del Figlio dell'uomo: Gesù collega ciò che viene fatto ai più piccoli a ciò che viene fatto a lui. La visita ai malati appartiene così alle opere di misericordia, cioè alle azioni con cui si soccorre concretamente chi soffre; non è una prestazione riservata a chi ha competenze sanitarie. La lettera di Giacomo non presenta la malattia come una faccenda privata: il malato chiama i presbiteri e costoro pregano su di lui nel nome del Signore. Il ruolo della comunità e il contesto di fede fanno parte del senso dell'unzione. «Presbiteri» si può rendere con «responsabili della comunità cristiana» nella lettera di Giacomo; per il sacramento celebrato nella Chiesa cattolica si precisa «sacerdoti, cioè vescovi e presbiteri» (Catechismo 1516). Il gesto non ha una causalità chimica, e dal versetto 15 non si deduce che ogni malattia derivi da un peccato personale.

Che cosa chiede l'Unzione

Qui nasce una difficoltà seria. Giacomo dice che il Signore solleverà il malato. Se il sacramento comunica l'aiuto di Dio, perché la persona potrebbe continuare a essere malata? Non basta rispondere che il rito è consolante. Bisogna capire che cosa promette la Chiesa e che cosa non promette.

Il Catechismo descrive il dono proprio dell'Unzione come grazia di conforto, pace e coraggio: grazia significa aiuto gratuito di Dio. Il malato viene sostenuto nella fiducia in lui e unito a Cristo, che ha conosciuto la sofferenza e la morte ed è risorto. Per la Chiesa, una persona malata non è esclusa da questo rapporto né diventa spiritualmente inutile perché non riesce più a fare ciò che faceva prima. Può continuare ad affidargli la propria vita. Questo è un contenuto della fede cristiana, non una previsione ricavata da un esame medico. [5]

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

La parola salvezza ha quindi un significato più ampio di guarigione. Riguarda la liberazione dal peccato e la vita con Dio, che per la fede cristiana non finisce con la morte. Non promette di vivere per sempre senza morire: la speranza è partecipare alla vita di Cristo risorto. Nel testo di Giacomo compare anche il perdono dei peccati. Non c'è scritto che il malato si sia ammalato perché è colpevole: il testo dice se ha commesso peccati. Il sacramento riguarda la persona intera, anche il suo rapporto con Dio; non autorizza chi la visita a giudicare l'origine della sua malattia. [6]

La Chiesa prega anche perché il corpo recuperi la salute. Non considera il corpo un involucro trascurabile. Ma il Catechismo precisa che neppure le preghiere più intense ottengono la guarigione di tutte le malattie. L'Unzione affida il malato a Cristo senza trasformare la fede in una garanzia di guarigione. Dalla mancata guarigione non possiamo concludere che quella persona abbia creduto troppo poco. E non possiamo misurare l'azione di Dio contando i momenti in cui riesce a essere serena: la paura può restare e ha bisogno di essere ascoltata. [7]

Resta un'altra obiezione: unire la sofferenza a Cristo significa che dobbiamo conservarla, magari evitando di alleviarla? La risposta della Chiesa è no. Giovanni Paolo II, parlando del significato cristiano della sofferenza, esclude la passività davanti a chi soffre. L'aiuto deve cercare di essere concreto ed efficace. Unirsi a Cristo significa affidarsi a lui dentro ciò che si vive; non significa cercare il dolore o assegnare al malato una prova di eroismo. Il sacerdote, il medico, l'infermiere e chi gli è vicino non si sostituiscono a vicenda. Hanno responsabilità diverse verso la stessa persona. [8]

Salvezza e guarigione

Il Catechismo (1520–1522) descrive la grazia di conforto, pace e coraggio, l'unione alla passione di Cristo e la dimensione ecclesiale; il n. 1532 distingue il perdono dei peccati e il recupero della salute, condizionato al bene spirituale. Il sacramento non è un effetto psicologico: la Chiesa vi riconosce un'azione reale di Cristo e un dono dello Spirito Santo. Questa efficacia non è uno stato d'animo garantito e misurabile: sentirsi ancora impauriti non dimostra da solo che il sacramento non abbia dato la sua grazia. Il Catechismo (1508) afferma espressamente che neppure le preghiere più intense ottengono la guarigione di tutte le malattie. Già il Concilio di Trento distingueva il sollievo e il rafforzamento spirituale dalla guarigione del corpo, possibile quando giova alla salvezza: Denzinger-Hünermann 1696. «Salvare» e «sollevare» hanno più significati: la dottrina non deriva da un solo vocabolo greco. La salvezza comprende la vita con Dio oltre la morte, non la promessa di evitare la morte fisica (Catechismo 1505 e 1523). *Sacramentum caritatis* 22 collega l'Unzione all'offerta di Cristo e al bene della comunità; ciò non implica esaltare il dolore. Secondo il Catechismo (1522), la Chiesa prega per il malato e il malato, unendosi liberamente a Cristo, partecipa al bene della Chiesa e degli altri. La reciprocità si capisce con l'esempio della preghiera del malato per gli altri: chi riceve aiuto può anche offrirlo nella preghiera. Il legame affermato è spirituale, in Cristo: non significa che più dolore procuri automaticamente un bene maggiore né che il malato debba dimostrare di essere utile soffrendo. *Salvifici doloris* 30 esclude la passività davanti alla sofferenza; il valore dell'amore non è una celebrazione della malattia.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Il sacramento durante la malattia

Questa distinzione aiuta a capire un equivoco sul momento in cui si riceve il sacramento. Il nome estrema unzione può far pensare che l'arrivo del sacerdote annunci la fine. Il nome ha una storia: nel corso dei secoli il sacramento fu conferito sempre più esclusivamente a chi era in punto di morte. Il gesto finì così per essere associato soprattutto agli ultimi momenti. [9]

Nel 1963 il Concilio Vaticano II precisò che è meglio chiamarlo Unzione degli infermi e che non è il sacramento soltanto di chi è in fin di vita. Il tempo opportuno comincia già quando una persona, per malattia o vecchiaia, entra in pericolo di morte. Non è dunque destinato a qualsiasi piccolo malessere, ma non occorre aspettare che il malato stia vivendo gli ultimi istanti. L'Unzione è un aiuto per vivere la malattia, non l'annuncio che la morte è imminente. [10]

Nel 1972 Paolo VI riformò il rito romano secondo l'indicazione del Concilio. Oggi il sacerdote unge con olio benedetto la fronte e le mani e prega perché il Signore aiuti, salvi e sollevi il malato. La Chiesa accompagna così una persona viva nella sua malattia; non applica una formula che garantisca un risultato medico. [11]

Ritorniamo allora alla cartella da cui siamo partiti. La diagnosi può rimanere e, insieme, può esserci ancora molto da fare: alleviare un sintomo, ascoltare una paura, sostenere un rapporto. Per un cristiano c'è anche la possibilità di ricevere il sacramento con cui la Chiesa lo affida a Cristo. La fede non toglie nessuno dei compiti dell'assistenza e non li riserva ai credenti. Aggiunge la fiducia che quella vita, anche nella sua fragilità, resta unita al Signore e aperta alla sua salvezza.

Se chiamiamo cura soltanto ciò che guarisce, quando la guarigione diventa impossibile rischiamo di considerare finito anche il nostro compito. La persona che abbiamo davanti ci chiede di guardare meglio. Non possiamo prometterle un esito che non conosciamo. Possiamo riconoscere i bisogni che ha e continuare a rispondere, ciascuno con la propria competenza. È questo il lavoro che la cartella rimasta aperta ci ha fatto vedere.

Dal nome al gesto

Sacrosanctum Concilium 73–75 permette e preferisce il nome «Unzione degli infermi» e precisa che il tempo opportuno comincia già quando il fedele è in pericolo di morte per malattia o vecchiaia. Non dice che il sacramento sia per qualsiasi malessere e non afferma che il Concilio abbia inventato un sacramento nuovo. Il Catechismo (1512–1513) documenta la progressiva concentrazione della prassi su chi stava morendo e la riforma di Paolo VI, Sacram Unctionem infirmorum, 30 novembre 1972. Nel rito romano l'unzione con olio benedetto avviene sulla fronte e sulle mani; la celebrazione comprende Parola, preghiera e imposizione delle mani (Catechismo 1513 e 1517–1519). Il sacramento può essere ripetuto in una nuova grave malattia o in caso di peggioramento nella stessa malattia (Catechismo 1515). Il viatico è l'Eucaristia per il passaggio alla vita eterna e non un altro nome dell'Unzione (Catechismo 1517; *Sacramentum caritatis* 22).

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Per lo studio

1. Perché un trattamento che allevia un sintomo può essere utile senza eliminare la malattia?

2. Perché accompagnare non significa semplicemente distrarre?

Curare significa occuparsi della persona anche quando non può guarire: per la Chiesa questa cura comprende l'Unzione, che affida il malato a Cristo senza promettergli una guarigione automatica.

Fonti

[1] Cicely Saunders, «The evolution of palliative care», *Journal of the Royal Society of Medicine* 94 (2001), pp. 430–432

[2] Bibbia CEI 2008, Mt 25,31–46, in particolare vv. 36 e 40

[3] Bibbia CEI 2008, Gc 5,14–15

[4] *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992, edizione tipica 1997), nn. 1509–1511 e 1520

[5] *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992, edizione tipica 1997), nn. 1520–1522

[6] Bibbia CEI 2008, Gc 5,15

[7] *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992, edizione tipica 1997), n. 1508

[8] Giovanni Paolo II, *Salvifici doloris* (11 febbraio 1984), nn. 28 e 30

[9] *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992, edizione tipica 1997), n. 1512

[10] Concilio Vaticano II, *Sacrosanctum Concilium* (4 dicembre 1963), n. 73

[11] *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992, edizione tipica 1997), nn. 1513 e 1516–1519

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati